ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

重症市中肺炎（sCAP） — 要約

解説「重症市中肺炎（sCAP）」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

詳しく

重症は基準で判定する

ICUにいるかではなくATS/IDSA基準で。病棟で遅れてsCAPになる患者（死亡48%）を見逃さない

βラクタム＋マクロライド

広域化は分離歴か「90日以内の入院かつ非経口抗菌薬」のときだけ。48時間で狭め、重症は5日以上

ステロイドは絞って入れる

重症・非インフルエンザ・高炎症・早期の患者に。インフルエンザには入れない

2 見つける — 基準で判定し、検体をセットで出す

詳しく

- **重症の定義**：大基準（昇圧薬を要するショック／人工呼吸を要する呼吸不全）1つ、または小基準3つ以上（呼吸数30以上・P/F 250以下・多葉性浸潤影・錯乱・BUN 20以上・白血球4,000未満・血小板10万未満・体温36℃未満・積極的な輸液を要する低血圧）
- **転帰**：ICUのCAPは30日死亡約30%、1年死亡47%。第4〜7病日に悪化した患者は死亡48%（入院時からなら17%）。最大30%は無熱なので、病棟では呼吸数・酸素需要・意識を毎日見る
- **スコアは用途で**：PSI・CURB-65は帰す判断用でICUの要否は予測しない。強力な呼吸補助の予測はSMART-COP
- **重症なら検体セット**：血液培養・下気道検体・肺炎球菌とレジオネラの尿中抗原・呼吸器ウイルスPCRを抗菌薬の前に（ただし遅らせない）。PCTで抗菌薬を始める判断はしない

3 抗菌薬 — 入口と出口を最初に決める

詳しく

場面	レジメン・判断	注意
リスク因子なし	セフトリアキソン2 g/日＋アジスロマイシン	足すのはキノロンではなくマクロライド。狭めても免疫調節目的で続けてよい
緑膿菌・MRSAのリスク	抗緑膿菌βラクタム＋マクロライド／3GC＋マクロライド＋リネゾリド	入院歴だけ・施設入所歴だけでは広域にしない（HCAPは廃止）
インフルエンザ	オセルタミビルを追加、抗菌薬も省かない	発症からの日数を問わない
48時間・3〜4日目	培養で狭める。CRPが30〜40%下がったか	MRSA鼻腔スワブ陰性なら抗MRSA薬を切る
期間	非重症は安定後5日未満（最短3日）、**重症は5日以上**	重症の5日以上はATS 2026の強い推奨。短期治療のRCTに重症はいない

4 ステロイドと呼吸補助

詳しく

重症CAPには入れる（死亡9.8%対15.1%、NNT 17）。非重症（強い推奨で投与しない）とインフルエンザ（ICU死亡HR 1.32）には入れない

▼

当たりやすい患者と用法

- 重症化から24時間以内・P/F 300未満・CRPやIL-6高値。72時間超では期待しにくい
- ヒドロコルチゾン200 mg/日の持続。血糖をq4〜6時間（140〜180 mg/dL）

呼吸補助

- de novoの低酸素はHFNCから（挿管RR 0.76）。COPD増悪・心原性肺水腫の合併はNIV
- SpO_2ではなく呼吸数・努力・一回換気量（9〜9.5 mL/kg超）で見切る

▼

ARDSに進んだら標準どおり：VT 6 mL/kg・プラトー30未満・駆動圧15未満、P/F 150未満で腹臥位16時間以上、基準を満たせばVV-ECMOを相談

5 原因別の一手と、改善しないとき

詳しく

- **誤嚥**：嫌気性菌が記録されるのは2〜4%。標準のCAPレジメンでよく、メトロニダゾールは足さない（例外は歯性疾患・肺膿瘍・膿胸）
- **レジオネラ**：尿中抗原は血清群1だけで感度70〜90%。陰性でも否定せず下気道PCR。βラクタムは効かず、レボフロキサシンかアジスロマイシン
- **非改善は3系統**：届いていない（耐性菌・MRSA・レジオネラ）／合併症（膿胸・膿瘍）／感染ではない（器質化肺炎・血管炎・薬剤性・心原性肺水腫）。5〜7日目は診断を疑い直しCTと気管支鏡、免疫不全なら初日からCTとBAL

- ☐ **無熱**で肺炎を否定しない
- ☐ **ウイルス陽性**でも入院例の抗菌薬を省かない
- ☐ **ステロイド中**はCRPと白血球を治療反応の目安にしない
- ☐ **退室時**に抗菌薬・ステロイドの終了日と心血管リスクを引き継ぐ

出典：本編の主要文献（ATS CAP 2026・ATS/IDSA 2019 AJRCCM；ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2023 ERJ；Dequin ICM 2026；Pitre ICM 2025；CAPE COD NEJM 2023；REMAP-CAP JAMA 2025 ほか）。ATS 2026はIDSAの承認がなく、推奨のエビデンスの質はすべて「低」か「非常に低い」です。用量は使う前に原著・添付文書・薬剤部の基準と照合してください。